

Paciente

Nombre: Ricardo Antonio Correa Monsalve

Identificación: 3521980

Sexo: M

Teléfono: 3117633907

Edad: 66año(s) 1ms.

Examen

Médico referente: Clinica Fundacion Colombiana

IPS: CTC-TUTELAS EPS SURA

Fecha del examen: 24/08/2026

Fecha de finalización: 28/08/2026 1:03:56 p. m.

Ciudad: MEDELL?N

ESTUDIO REALIZADO: RESONANCIA DE ABDOMEN CONTRASTADA

INDICACIÓN:

Antecedente de adenocarcinoma de páncreas

TÉCNICA:

En equipo de 1.5 T se realizan secuencias axiales T1 y T2 con y sin saturación grasa. T1 en fase y fuera de fase y secuencias coronales T1 y T2 del el abdomen superior.

Posterior a la administración de medio de contraste endovenoso se realizaron secuencias axiales dinámicos T1 con saturación grasa y secuencia coronal T1.

Secuencias de colangiorm 2D y 3D.

Gadovist 6.2 cc sin complicaciones

HALLAZGOS:

El hígado se encuentra aumentado de tamaño, el lóbulo derecho mide 19 cm de diámetro longitudinal, observando múltiples lesiones focales en el lóbulo derecho e izquierdo, hipointensas en las secuencias T1 y de intensidad de señal intermedia en las secuencias T2, con realce anular y áreas de restricción a la difusión relacionadas con metástasis. Las de mayor tamaño se localizan uno en el segmento 4b de 41 mm y otra entre el segmento 8 y 4a de 35 mm. No eran visualizadas en la resonancia previa de enero del 2026.

No se observan cambios de infiltración grasa hepática

Páncreas de tamaño y posición normal.

Se observa una masa de contornos mal definidos localizada en la región portocava y comprometiendo la cabeza del páncreas sin plano de clivaje, con realce postcontraste e intensidad de señal intermedia en las secuencias T2 con áreas hiperintensas en su interior por necrosis.

Contacta la pared anterior de la vena cava inferior sin plano de clivaje. Mide 42 x 22 mm. Presenta aumento en su tamaño con respecto al estudio previo de enero del 2026. Contacta la vena porta principal. No compromete el tronco celíaco ni la arteria mesentérica superior

No se observan lesiones en el cuerpo y cola del páncreas ni signos de pancreatitis crónica.

No se observa dilatación del conducto pancreático

Se observan adenopatías en el hilio hepático y a nivel portocava , la de mayor tamaño mide 57 x 48 mm localizada en el hilio hepático en íntimo contacto con el lóbulo caudado sin plano de clivaje, engloba demás la arteria hepática. Presenta realce heterogéneo y restricción a la difusión .No era visualizada en el estudio previo

Vesícula biliar ausente por antecedente quirúrgico

Nombre: Ricardo Antonio Correa Monsalve
Identificación: 3521980

Fecha del examen: 24/08,
Fecha de finalización: 28/08/2026 1:03:56 p. m.

Dilatación de la vía biliar intrahepática.
Cambios postquirúrgicos por anastomosis bilioentérica.

Bazo y glándulas suprarrenales de tamaño, posición e intensidad de señal normal, sin definir lesiones focales.

Aorta de calibre normal.

Vena porta y venas suprahepáticas permeables.

Riñones de tamaño normal. El riñón derecho de una localización más inferior sugiriendo ptosis.
Pequeños quistes simples menores de 10 mm

No se observa dilatación de las cavidades pieloclectoras.

No se aprecia líquido en la cavidad peritoneal.

Cambios postquirúrgicos en la pared abdominal

Lesión focal en L3 sugestiva de hemangioma óseo sin cambios con respecto al estudio previo

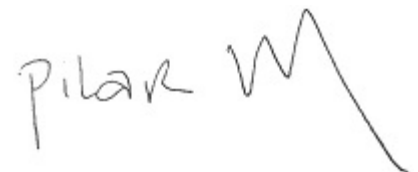
CONCLUSION:

Lesión de aspecto infiltrativo tumoral localizada entre la región portocava y cabeza del páncreas, contactando la vena porta principal y la vena cava inferior asociado a metástasis hepáticas y adenopatías en el hilio hepático, con signos de progresión oncológica al comparar con el estudio previo.

Hepatomegalia

Pequeños quistes simples renales Bosniak I

Ver descripción.



Maria Del Pilar Montoya Arango
Médica Radióloga RM 52764-03 Imagen
Corporal.

Nombre: Ricardo Antonio Correa Monsalve
Identificación: 3521980

Fecha del examen: 24/08,
Fecha de finalización: 28/08/2026 1:03:56 p. m.

Tecnólogo: Juan Camilo Alvarez Quintero